

1) Un paciente de 68 años presenta constipación de dos meses de evolución, asociada a anemia ferropénica. Se solicita una colonoscopia, que muestra un tumor de 6 cm de diámetro en el colon sigmoidees, el que es biopsiado, mostrando un adenocarcinoma invasor de diferenciación intermedia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis y tórax como etapificación
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Realizar quimioterapia
- d) Solicitar PET-TC de abdomen y tórax
- e) Realizar resección del tumor mediante colonoscopia

2) Una paciente es despedida de su trabajo, en el que llevaba cerca de 10 años. Durante el mes siguiente presenta ánimo depresivo y llanto frecuente, ya que piensa que no conseguirá otro trabajo y que no podrá pagar sus deudas. Por esto tiene dificultades para dormir, ya que despierta muy temprano con la idea de que es una fracasada y está llena de problemas y también tiene dificultades para quedarse dormida. Refiere que llora casi todos los días, por lo menos 5 veces y que no tiene ganas de hacer nada. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Distimia
- c) Trastorno adaptativo
- d) Fobia social
- e) Trastorno de estrés postraumático

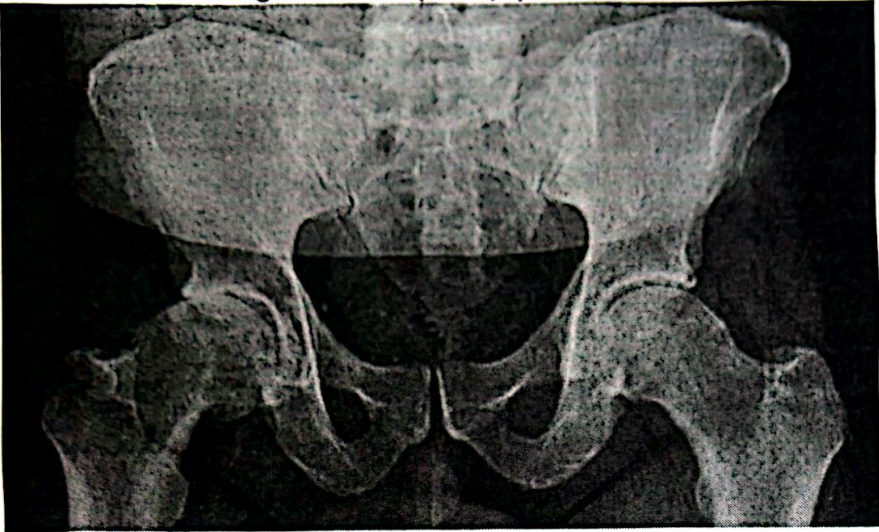
3) Una mujer siente que sus piernas son horribles, en especial sus rodillas, las que considera deformes, razón por lo que no usa traje de baño ni ropa corta, sino solo faldas largas o pantalones sueltos. Al ser enfrentada, El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno obsesivo compulsivo
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno dismórfico corporal
- d) Trastorno por hipocondría
- e) Trastorno fóbico social

4) ¿Cuál de las siguientes opciones justifica la realización de pruebas tamizaje para una enfermedad?

- a) Muy baja frecuencia
- b) Ausencia de un tratamiento eficaz disponible
- c) Presencia de síntomas desde los primeros días de la enfermedad
- d) Alta contagiosidad y letalidad
- e) Alto riesgo de progresión a complicaciones graves o irreversibles

5) Un paciente de 78 años consulta por dolor en ambas ingles, irradiado a los muslos, que inició hace 5 años y que es más intenso al caminar, lo que ha limitado su movilidad en el último tiempo. Se solicita una radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Displasia de caderas ✗
- b) Metástasis óseas
- c) Necrosis avascular de la cabeza femoral bilateral ✗
- ☒ d) Sacroileítis ✗
- e) Coxoartrosis bilateral ✓

6) Un paciente de 18 años presenta epistaxis derecha de 3 meses de evolución, que ha sido intermitente, pero que ha aumentado de frecuencia. Además, refiere que hace 1 mes siente la fosa nasal derecha totalmente tapada. No fuma, ni consume sustancias y no refiere otras molestias. Consulta ahora por epistaxis, que empezó hace 30 minutos y que no ha parado. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer nasal
- b) Cuerpo extraño nasal
- ☒ c) Nasofibroangioma ✓
- d) Sinusitis crónica ✗
- e) Mucormicosis

7) Un paciente de 18 años presenta placas levemente eritematosas, con descamación suave en el tronco, de 5 días de evolución, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis ✗
- ☒ b) Dermatitis seborreica ✓
- c) Psoriasis guttata
- d) Pitiriasis versicolor ✗
- e) Pitiriasis rosada ✓

8) Un paciente de 22 años presenta desde hace 5 días, aparición de una lesión eritematosa muy pruriginosa en la cara latero-dorsal de los dedos pulgar, índice y medio derecho, con múltiples vesículas tensas, muy pruriginosas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Liquen simple
- c) Liquen plano
- d) Eccema dishidrótico
- e) Dermatitis atópica

9) Un paciente de 35 años consulta por dolor lumbar izquierdo, muy intenso, irradiado al testículo ipsilateral. Además, ha vomitado en varias ocasiones. Al examen físico se aprecia sudoroso, cambia continuamente de posición y se queja continuamente. La conducta más adecuada para el tratamiento del paciente descrito es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Administrar ketorolaco endovenoso ✓
- c) Administrar haloperidol endovenoso
- d) Enviar a domicilio con paracetamol oral
- e) Resolver quirúrgicamente

10) Una paciente de 60 años consulta por hematuria de 2 semanas de evolución. Su examen físico es normal, por lo que se solicita un sedimento de orina, que resulta normal; un urocultivo, que resulta negativo y una ecografía renal y vesical, que resulta también normal. El estudio debe proseguir con:

- a) Baciloscopia de orina
- b) Resonancia magnética nuclear
- c) Cintigrafía
- d) Tomografía axial computada
- e) Cistoscopia

11) Un paciente de 69 años, muy fumador, presenta dolor en las pantorrillas que aparece al caminar 100 metros y que se hace insoportable a los 200 metros, por lo que debe detenerse. Al examen físico presenta índice tobillo/brazo: 0,7 y disminución de los pulsos pedios, sin otras alteraciones. Además de dejar de fumar y controlar los factores de riesgo cardiovascular, la conducta más adecuada es:

- a) Solicitar angiografía
- b) Anticoagular con heparina y realizar endarterectomía
- c) Realizar by pass
- d) Indicar ejercicios de caminata e iniciar aspirina y atorvastatina
- e) Indicar anticoagulación con TACO

12) Un niño de 5 meses de edad presenta epífora bilateral, asociada a opacidad de ambas córneas. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinoblastoma
- b) Atresia del conducto nasolagrimal
- c) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
- d) Queratitis herpética
- e) Glaucoma congénito

13) Un paciente de 71 años, viudo, presenta cuadro de ánimo bajo y disminución de sus actividades. Él refiere que se siente bien, sin embargo, la hija refiere que puede estar deprimido. Se realiza un test de Minimental, que resulta normal y una prueba GDS que resulta 12/15 puntos. ¿Cuál es el fármaco de elección?

- a) Paroxetina ✓
- b) Sertralina
- c) Mirtazapina ✕
- d) Diazepam ✕
- e) Amitriptilina ✕

14) Paciente de 19 años de edad, consulta por ojo rojo izquierdo, asociado a dolor, prurito y sensación de arenilla local de dos días de evolución. Al examen físico destaca reacción tarsal folicular y presencia de adenopatías delante y detrás de la oreja ipsilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis bacteriana
- b) Conjuntivitis vírica
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Queratitis punctata
- e) Queratitis por cuerpo extraño

15) Un paciente de 34 años consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, duro, que asciende con la deglución. Se solicita una ecografía que lo visualiza de aspecto sólido, sin adenopatías cervicales asociadas. Se realiza una punción aspirativa con aguja fina, obteniéndose una citología compatible con un carcinoma folicular (lesión folicular con displasias de alto grado). La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento con yodo radiactivo
- b) Realizar tiroidectomía total y seguir con niveles plasmáticos de calcitonina
- c) Realizar tiroidectomía total, con linfadenectomía cervical
- d) Realizar tiroidectomía total y en segunda instancia tratar con yodo radiactivo
- e) Realizar tiroidectomía parcial e iniciar levotiroxina en dosis altas

16) Un paciente está en tratamiento con sertralina, desde hace 1 mes, por un episodio depresivo mayor. Desde hace 2 semanas anda más irritable y agresivo, con peleas frecuentes con sus familiares. Además, fue despedido de su trabajo porque insultó a su jefe y se ha involucrado con 4 parejas sexuales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Depresión severa con síntomas psicóticos
- e) Psicosis por fármacos

17) Un paciente de 23 años, luego de una ruptura sentimental con su pareja, evoluciona con amnesia parcial de lo ocurrido y una actitud extraña. A la entrevista está perplejo y resignado a lo que estaba sucediendo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo ✗
- b) Trastorno disociativo ✗
- c) Trastorno somatomorfo —
- d) Episodio psicótico reactivo —
- e) Trastorno depresivo ✗

18) Múltiples estudios demuestran que un factor de riesgo tiene un riesgo relativo entre 3 y 4 para la aparición de una enfermedad. ¿A qué criterios de causalidad de Hills corresponde esto?

- a) Replicabilidad ✗
- b) Congruencia —
- c) Plausibilidad biológica ✗
- d) Secuencia temporal —
- e) Asociación —

19) Se desea evaluar la efectividad de un nuevo antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para esto, ¿Qué tipo de estudio escogería, por dar una mejor información?

- a) Caso control
- b) Metanálisis
- c) Cohorte
- d) Corte transversal
- e) Estudio clínico randomizado

20) Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él "no puede hacerlo". Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico ✗
- b) Trastorno de la personalidad evitativo ✗
- c) Ansiedad social ✗
- d) Trastorno de ansiedad generalizada —
- e) Agorafobia —

21) Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en aducción, rotación interna y ligera flexión. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de cadera
- b) Fractura intertrocantérica
- c) Fractura de cuello femoral
- d) Luxación posterior de cadera
- e) Fractura de pelvis

22) Un paciente de 8 años, sin antecedentes, es traído por presentar múltiples pápulas de 3-4 milímetros de diámetro en manos, tórax y extremidades, algunas de ellas agrupadas en forma lineal, asociado a prurito ocasional. El diagnóstico más probable:

- a) Molusco contagioso
- b) Fibromatosis ✗
- c) Liquen plano ✗
- d) Verrugas planas
- e) Dermatitis atópica ✗

23) Un paciente de 80 años, presenta una obstrucción intestinal, debido a un vólvulo de colon sigmoides. Se realiza descompresión neumática por colonoscopia, con adecuada respuesta. Usted lo controla un mes después, sin síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada con este paciente?

- a) Educar y observar evolución
- b) Realizar fijación endoscópica del colon sigmoides
- c) Realizar cirugía de Hartmann
- d) Solicitar colonoscopia y decidir conducta según hallazgos
- e) Recomendar sigmoidectomía electiva

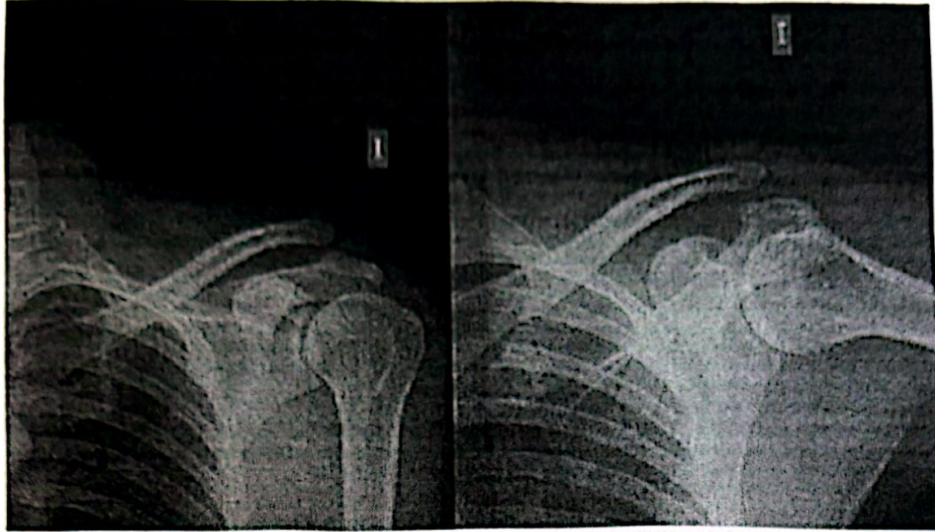
24) Una mujer de 35 años, sin antecedentes, consulta porque está segura de que todos sus compañeros de trabajo la seducen y la acosan, esto le ocurre desde hace aproximadamente 10 años y le ha traído problemas en su trabajo, por lo que ha sido despedida en otros trabajos. No refiere presentar problemas en otros ámbitos de su vida, tiene buena relación con familiares y amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno de personalidad histriónico
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de la personalidad esquizotípico

25) Una paciente de 76 años, con antecedente de arteritis de células gigantes, consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de inicio súbito, hace 2 horas. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un gran escotoma derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Desprendimiento de retina —
- b) Trombosis de la vena central de la retina —
- c) Trombosis de arteria central de la retina
- d) Neuritis óptica
- e) Neuropatía óptica isquémica

26) Un paciente de 24 años, sufre una caída a nivel, mientras jugaba básquetbol, cayendo con el hombro izquierdo, contra el suelo. Presenta impotencia funcional y al examen físico destaca dolor a la movilización del hombro izquierdo. Se solicita una radiografía AP de hombro y axial de escápula, que se muestran a continuación:



El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de hombro
- b) Fractura de escápula
- c) Luxación acromioclavicular x
- ☒ d) Fractura de clavícula —
- e) Lesión del tendón del manguito rotador

27) Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace meses, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 42 UI/L, GPT: 63 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L y bilirrubina de 6,4 mg/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- a) TAC de abdomen
- b) Ecografía abdominal ,
- c) Endoscopía digestiva alta y biopsia
- ☒ d) Colangiografía resonancia Ⓞ
- e) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica → HTO .

28) Mujer de 81 años, con antecedente de enfermedad de Parkinson, hospitalizada por una neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario y no reconoce a sus familiares. En el día, por el contrario, está en buenas condiciones, tranquila y no recuerda lo sucedido. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para su manejo?

- a) Lorazepam
- b) Risperidona
- c) Quetiapina
- ☒ d) Haloperidol
- e) Donepecilo

29) Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

- a) Infección urinaria
- b) Filtración de la anastomosis
- c) Reacción adversa a medicamentos
- ☒ d) Tromboembolismo pulmonar ✓
- e) Atelectasia infectada

30) En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determinad que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer. ¿Qué medida es posible calcular con esta información?

- a) Incidencia acumulada en los pacientes fumadores
- ☒ b) Prevalencia en los pacientes fumadores ✓
- c) Riesgo relativo
- d) Odds ratio
- e) Tasa de ataque en los pacientes fumadores

31) Paciente femenina de 35 años, quien evidencia masa en cuadrante superoexterno de mama izquierda, no doloroso, de consistencia lisa y no adherido a planos profundos. Tiene una tía fallecida de cáncer de mama a los 71 años y usa anticonceptivos orales. La conducta más apropiada es:

- ☒ a) Realizar ecotomografía de mamas _
- b) Realizar mamografía _
- c) Punción con aguja fina
- d) Realizar tumorectomía y biopsia
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

32) ¿Cuál es la mejor estrategia de vigilancia para una enfermedad infectocontagiosa, que se transmite a través de la contaminación de acuíferos?

- a) Vigilancia activa
- ☒ b) Vigilancia pasiva
- c) Vigilancia estacional
- d) Encuestas
- ☒ e) Centros centinelas

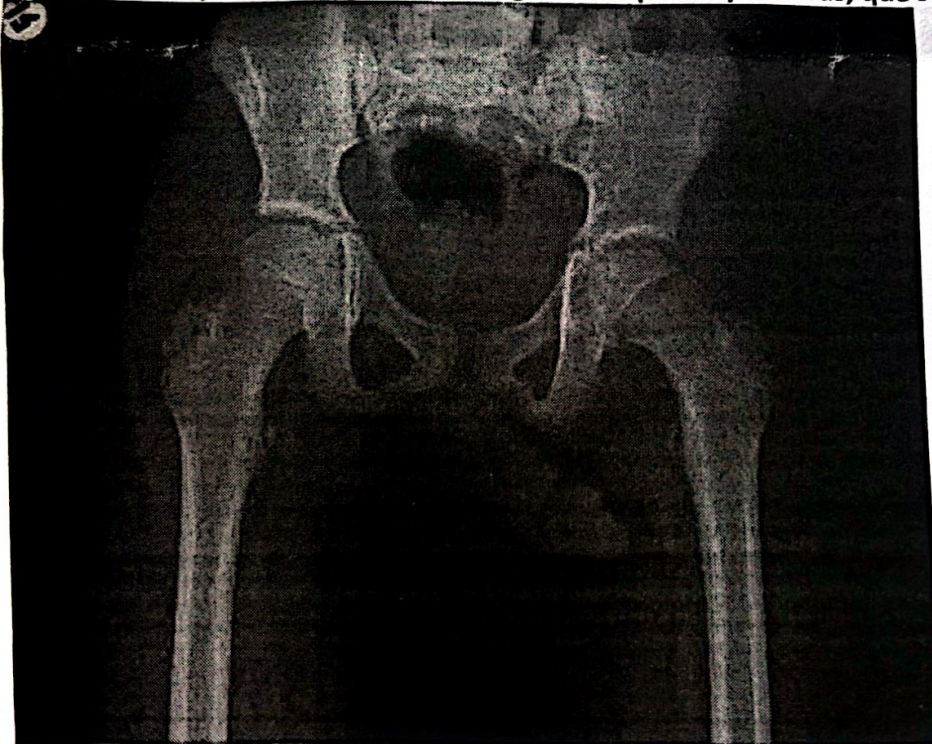
33) Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Celulitis
- ☒ b) Erisipela
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Dermatitis de contacto irritativa
- e) Plodermitis superficial

34) Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación:



El diagnóstico es:

- ☒ a) Displasia del desarrollo de la cadera ✓
- b) Epifisiolisis
- c) Fractura del cuello del fémur ✗
- d) Luxación de la Cadera izquierda —
- e) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

35) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA en la actualidad**?

- a) Los pacientes Fonasa A y B no copagan en la modalidad Institucional
- b) Los pacientes Fonasa A y B no copagan en en la atención primaria pública (ej. consultorios) ✓
- c) Los pacientes Fonasa C y D no copagan en la atención primaria pública (ej. consultorios) ✓
- d) Los pacientes Fonasa C y D no copagan en la modalidad Institucional
- e) Los pacientes Fonasa C y D no copagan en las prestaciones GES ✓

36) Una paciente de 32 años dice que es la esposa de Dios y que dará a luz al nuevo Jesús. Refiere que Dios y los ángeles le hablan y le dicen que es muy especial y que en ocasiones el hijo que lleva dentro se comunica telepáticamente con ella. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Manía aguda con síntomas psicóticos
- d) Trastorno de personalidad esquizotípica
- e) Trastorno de personalidad narcisista

37) Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno evitativo de la personalidad —
- b) Síndrome de Asperger
- c) Depresión mayor
- d) Distimia
- e) Fobia social —

38) Un joven 17 años, comienza tratamiento con risperidona 3mg al día, hace 1 semana, por esquizofrenia primer brote. Presenta contracción cervical, mantenida y recurrente, que se acompaña de dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Distonía aguda
- b) Disquinesia tardía
- c) Acatisia
- d) Trastorno conversivo
- e) Parkinsonismo por drogas

39) ¿Cuál de las siguientes opciones es una alternativa recomendada para el manejo de la vía aérea de un paciente con vía aérea difícil, que acude a una cirugía electiva?

- a) Intubación a 6 manos
- b) Intubación sin hiperextender el cuello ✓
- c) Uso de dispositivos de intubación, como el Fastrach
- d) Intubación en secuencia rápida X
- e) Traqueostomía X

40) Un paciente de 69 años presenta deterioro cognitivo, con alteraciones de la memoria reciente, asociado a caídas, rigidez y movimientos de tipo extrapiramidales. Además, tiene alucinaciones visuales complejas con cierta frecuencia. No presenta focalidad neurológica y es capaz de invertir series. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia frontotemporal
- b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Delirium
- d) Demencia de Alzheimer
- e) Hidrocefalia normotensiva

41) Un paciente sufre una torsión del tobillo izquierdo, mientras bajaba escaleras, evolucionando con intenso dolor. Presenta imposibilidad de apoyar el pie y al examen se aprecia equimosis en la zona medial y anterior del pie. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Hemartrosis
- b) Luxación de tobillo
- c) Esguince de tobillo
- d) Fractura de tobillo
- e) Contusión de tobillo

42) Un paciente de 25 años consulta por aumento de volumen escrotal. Al examen físico se aprecia aumento de volumen escrotal izquierdo, de consistencia blanda, sin afectación del testículo, el que se palpa normal. El aumento de volumen aumenta al realizar maniobras de Valsalva y se solicita una ecografía testicular que confirma la presencia de un varicocele de tamaño moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar ligadura de los plexos pampiniformes
- b) Solicitar marcadores tumorales
- c) Solicitar ecografía renal y vesical
- d) Observar evolución
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

43) Un paciente de 65 años presenta disuria de esfuerzo y disminución del calibre del chorro miccional, asociado a nicturia y 3 episodios de infección urinaria, que han respondido al tratamiento antibiótico oral. Su tacto rectal es compatible con una hiperplasia prostática, sin nódulos y su APE es normal. Se solicita una ecografía prostática y vesical, que resulta compatible con un adenoma de 30 cc. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia prostática transrectal
- b) Iniciar alfabloqueantes
- c) Derivar para cirugía abierta
- d) Derivar para resección transuretral
- e) Iniciar bloqueadores del receptor de testosterona

44) ¿Cuál de las siguientes actividades o medidas, está relacionado con el principio de oportunidad de las garantías explícitas de salud (GES)?:

- a) Vigilancia epidemiológica
- b) Vigilancia del cumplimiento de plazos
- c) Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
- d) Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud
- e) Autorización sanitaria de prestadores y laboratorios

45) Se realiza un estudio que demuestra que los niños de las familias de altos ingresos tienen una prevalencia de trastorno por déficit atencional 3 veces mayor que la de los niños de las familias de menores ingresos. Sin embargo, se observa que los niños de familias de mayores ingresos tienen un número mucho mayor de atenciones de tipo psicológica y psicopedagógica, en las que podrían ser diagnosticados. ¿Qué tipo de sesgo es posible identificar?

- a) Sesgo de selección ✕
- b) Sesgo de confusión ✕
- c) Sesgo de notificación ✕
- ☒ d) Sesgo de vigilancia -
- e) Sesgo de información ✓

46) Un paciente de 62 años, acude a la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad) por un cuadro de lumbago, que inició cuando cargaba un mueble en el trabajo. Al ser atendido, el médico le explica que la patología por la que consulta es de tipo degenerativa y se debe a debilidad de la musculatura de su espalda, por lo que le dará una licencia médica tipo 1 (por enfermedad común) y la ACHS no cubrirá ningún examen. Él quiere reclamar, alegando que el mueble era muy pesado y que nunca antes había presentado este tipo de lesiones. ¿Dónde debe hacerlo?

- a) En la Compín
- b) En la subsecretaría de Redes Asistenciales
- ☒ c) En la Superintendencia de Seguridad Social
- d) En la Seremi de Salud
- e) En la Superintendencia de Salud

47) Un paciente de 21 años es poco expresivo y no le interesan mucho las relaciones interpersonales. No tiene amigos íntimos y nunca ha tenido pareja ni relaciones sexuales. Él refiere que no le vive "feliz sin esas cosas". Además, evita actividades en las que deba tener mucho contacto con los demás, ya que disfruta más de las actividades en solitario. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno de personalidad
- ☒ d) Trastorno del espectro autista
- e) Trastorno distímico

48) Un paciente de 64 años, bebedor habitual, comienza con dolor abdominal recurrente, que se presenta luego de comer y luego de consumir alcohol. Su examen físico es normal y en sus exámenes generales destaca glicemia basal: 170 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Angina mesentérica
- b) Hepatocarcinoma
- c) Pancreatitis crónica
- ☒ d) Cáncer de páncreas
- e) Colelitiasis

49) Un paciente de 60 años consulta por dolor anal muy intenso, que inició hace algunas horas. Al examen físico se aprecia una masa violácea, que protruye a través del ano, imposible de reducir y que es muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de recto
- b) Hemorroide externo trombosado
- c) Fluxión hemorroidal
- d) Absceso perianal
- e) Prolapso hemorroidal grado 4

50) Un paciente de 63 años, monorroeno de nacimiento, se detecta un tumor renal izquierdo de 3 cm de diámetro, de aspecto sólido en la ecografía, ubicado en el polo superior del riñón. El TAC de abdomen y pelvis no visualiza adenopatías. La conducta es:

- a) Realizar nefrectomía radical más radioterapia y quimioterapia postoperatorias
- b) Realizar nefrectomía parcial
- c) Realizar nefrectomía radical
- d) Observar evolución
- e) Realizar nefrectomía parcial más radioterapia postoperatoria

51) ¿Cuál de los siguientes trastornos de personalidad se caracteriza por agresividad, impulsividad, inestabilidad emocional y escisión de la personalidad?

- a) Esquizotípico
- b) Antisocial
- c) Histriónico
- d) Límite
- e) Paranoide

52) Acude a urgencias un paciente de 20 años, con un cuadro sugerente de un neumotórax espontáneo. Además, tiene antecedente de haber sufrido uno, el año pasado, el que fue manejado con pleurocentesis. Se solicita una radiografía de tórax, que confirma el diagnóstico, demostrando la presencia de un neumotórax derecho, del 30% del campo pulmonar. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos y observar por 4 a 6 horas, controlando con una nueva radiografía de tórax
- b) Realizar aspiración con jeringa y llave de 3 pasos
- c) Iniciar analgesia e instalar un tubo pleural con trampa de agua, sin necesidad de cirugía
- d) Conectar a ventilación mecánica con presión positiva
- e) Resolver quirúrgicamente

53) Paciente de 21 años, previamente sano, inicia fiebre, malestar general, cefalea y rinorrea purulenta. Refiere además disminución del olfato y obstrucción nasal izquierda. Al examen físico sólo se aprecia faringe eritematosa, sin exudado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo extraño nasal
- b) Amigdalitis aguda estreptocócica
- c) Neumonía
- d) Gripe
- e) Sinusitis aguda

54) Un paciente de 54 años consulta por presencia de un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, cuya ecografía lo visualiza de aspecto sólido, sin adenopatías cervicales asociadas. Se realiza una punción aspirativa con aguja fina, obteniéndose una citología compatible con un carcinoma folicular (lesión folicular con displasias de alto grado), por lo que se procede a tiroidectomía total. ¿Qué examen es más adecuado para realizar el seguimiento de este paciente, de modo de detectar precozmente una recidiva?

- a) Niveles plasmáticos de tiroxina
- b) Niveles plasmáticos de tirotropina
- ☒ c) Niveles plasmáticos de tiroglobulina
- d) Niveles plasmáticos de triyodotironina
- e) Captación de yodo radiactivo

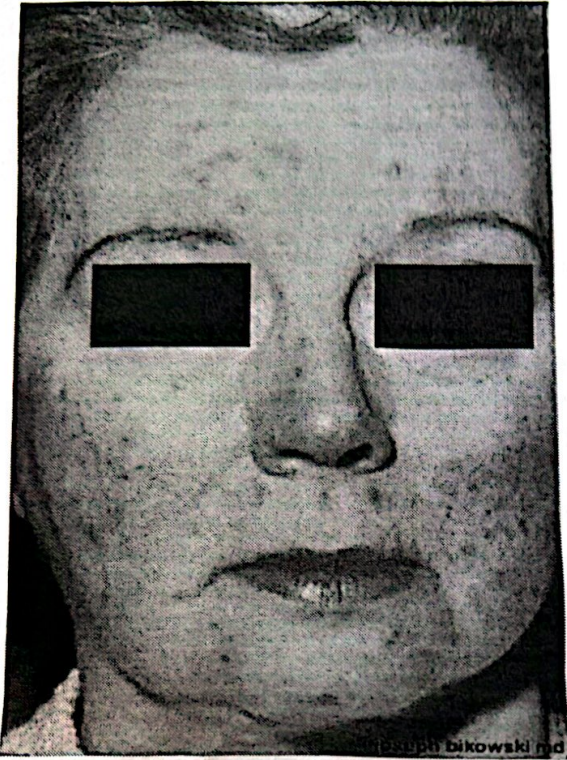
55) Un paciente de 65 años consulta por dolor abdominal muy intenso, asociado a vómitos alimentarios. En sus exámenes se solicita hemograma, que muestra claro aumento de los glóbulos blancos. Además, se solicita lipasa plasmática, que resulta 625 UI/L. El TAC de control muestra necrosis del 50% del páncreas, con reacción inflamatoria periférica. El paciente evoluciona desfavorablemente, con deterioro del estado general y hemodinámico, por lo que se decide realizar una punción pancreática, la que muestra un cultivo positivo para Klebsiella pneumoniae. La conducta más adecuada es:

- ←
- ☒ a) Indicar antibióticos endovenosos y resolver mediante debridación quirúrgica
 - b) Realizar punción aspirativa de la necrosis e iniciar tratamiento antibiótico
 - c) Indicar antibióticos endovenosos y régimen cero
 - d) Resolver quirúrgicamente, sin necesidad de antibióticos
 - e) Indicar antibióticos orales y régimen cero

56) Un paciente de 17 años consulta por rinorrea acuosa, asociada a obstrucción nasal bilateral, de dos algunos años de evolución, pero que ha aumentado en el último mes. Refiere prurito nasal y al examen físico se aprecia ojeroso, con mucosa nasal pálida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar clorfenamina oral
- b) Solicitar flujometría nasal
- ☒ c) Iniciar corticoides tópicos nasales
- d) Solicitar prick test, eosinófilos nasales y niveles plasmáticos de IgE
- e) Indicar vasoconstrictores nasales tópicos

57) Una paciente consulta por ardor ocular, asociado a enrojecimiento de la cara. Al examen físico se aprecia eritema de los párpados y de las mejillas y frente, con abundantes pápulas y pústulas sobre las áreas eritematosas. El diagnóstico más probable es:



- a) Lupus eritematoso sistémico ✗
- b) Acné conglobata ✗
- c) Lupus cutáneo subagudo ✗
- d) Rosácea
- ☒ e) Dermatomiositis

58) Un paciente de 76 años, fumador de una cajetilla al día, consulta por disfonía, que ha ido en aumento. Sin otras alteraciones. Su examen físico no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de epiglótico
- ☒ b) Cáncer de glótico
- c) Cáncer de hipofaringe
- d) Laringitis crónica ✗
- e) Disfonía funcional ✗

59) Un paciente de 35 años sufre una patada en la pierna derecha, mientras jugaba fútbol, con desplazamiento de la tibia hacia posterior, a nivel de la rodilla. Evoluciona con dolor intenso e imposibilidad de caminar. Además, en el examen es posible luxar la tibia hacia posterior, así como con signos de derrame articular. Se solicita una radiografía de rodilla derecha, que no evidencia rasgos de fractura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Rotura meniscal bilateral
- ☒ b) Rotura del ligamento cruzado anterior
- c) Rotura del ligamento rotuliano
- d) Rotura del ligamento colateral medial
- e) Rotura del ligamento cruzado posterior

60) Una paciente de 34 años consulta porque sale poco de su casa. Refiere que tiene mucho miedo de que una turba la ataque o a que quemen su casa. Además, ha tenido pesadillas con monstruos que se meten a su casa y que matan a su familia. Los síntomas iniciaron luego de fuertes protestas, que ocurrieron hace algunos meses, en las que hubo destrozos y fallecidos. En una oportunidad salió a comprar y cuando empezó a reunirse gente tuvo una crisis de pánico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Fobia específica
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de pánico
- ☒ d) Trastorno de angustia generalizada
- ☒ e) Trastorno de estrés postraumático

61) Un paciente de 20 años, estudiante de arquitectura, comienza a consumir marihuana con frecuencia, reprobando la mayoría de sus asignaturas. Previo a esto, consumía alcohol los fines de semana y su rendimiento era bueno. Fuma cerca de 4 "pitos" al día y, además, consume galletas y brownies. Al entrevistarle, él se muestra tranquilo, de buen ánimo y explica que no le importa mayormente su rendimiento, ya que no le interesa ganar dinero. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Síndrome de abstinencia
- b) Psicosis inducida por drogas
- c) Esquizofrenia
- d) Síndrome amotivacional
- ☒ e) Distimia

62) Una paciente de 64 años presenta disminución de la visión del derecho, de 6 meses de evolución, que actualmente le dificulta la lectura. Su agudeza visual es 20/80 en el ojo izquierdo y 20/40 en el derecho. Tiene antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo. La inspección ocular es normal, al igual que el rojo pupilar. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar campimetría visual
- b) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- ☒ c) Realizar fondo de ojo
- d) Indicar lentes biconvexos para la lectura
- e) Indicar lentes biconcavos para la lectura

63) Un recién nacido de término, sin antecedentes de importancia, presenta vómitos abundantes a las 12 horas de haber nacido, lo que se repiten al día siguiente, después de mamar y que son de aspecto lácteo-bilioso. Al examen físico se observa distensión epigástrica, que se normaliza luego de los vómitos. No ha tenido deposiciones. ¿Qué examen es más adecuado para establecer el diagnóstico?

- a) Radiografía de abdomen simple -
- b) Ecografía abdominal
- c) 17-OH-progesterona
- d) pH-metría esofágica
- e) Endoscopia digestiva alta

64) Una paciente de 35 años, presenta dolor en el epigastrio e hipocondrio izquierdo, de un día de evolución, asociado a múltiples vómitos, que ha cedido parcialmente al uso de analgésicos y antiespasmódicos automedicados. Además, en las últimas horas, nota ictericia de las escleras y oscurecimiento de la orina. Al examen físico tiene dolor a la palpación del hemiabdomen superior, sin signos peritoneales, ictericia franca de piel y mucosas. Se solicita una ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10 mm de diámetro, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Coledocolitiasis
- e) Colangitis aguda

65) Una paciente de 40 años, ejecutiva de un banco, comienza a realizar actividades de excursión a las montañas (trekking). Hace dos semanas presentó dolor en la rodilla derecha, que fue haciéndose más intenso, a medida que bajaba, lo que dificultó mucho el descenso. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la tuberosidad tibial y la zona inmediatamente proximal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

- a) Disfunción patelofemoral
- b) Síndrome de la banda íleo tibial -
- c) Tendinitis de la pata de ganso
- d) Tendinitis rotuliana
- e) Tendinitis del tendón del cuádriceps

66) Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

- a) Acrocordones
- b) Intértrigo candidiásico -
- c) Impétigo buloso
- d) Tiña corporis
- e) Psoriasis

67) Una paciente de 55 años se lava las manos recurrentemente, porque siente que se encuentran sucias. El hecho de no hacerlo rápidamente le causa gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido para ella, pero no puede evitarla, ya que siente que puede estar infectada con virus y bacterias de todo tipo. ¿Qué fármacos son más adecuados para su manejo?

- a) Benzodiacepinas
- b) Antipsicóticos típicos
- c) Antipsicóticos atípicos
- ☒ d) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- e) Antidepresivos duales

68) Un paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por dolor testicular que inició hace una hora, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico se aprecia testículo derecho ascendido respecto al contralateral y escaso eritema circundante. La conducta más adecuada en este caso es:

- a) Realizar ecografía testicular
- b) Indicar doxiciclina y ciprofloxacino
- c) Indicar ketorolaco endovenoso y suspensión testicular
- ☒ d) Realizar exploración quirúrgica inmediata
- e) Solicitar hemograma, parámetros inflamatorios y sedimento de orina; decidir conducta según resultados. —

69) Desde el año 2005 existe la ley que obliga a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad con el objetivo de disminuir traumatismos asociados a accidentes. Con respecto a esta ley, en términos de prevención, corresponde a:

- ☒ a) Prevención primaria
- b) Promoción de salud
- c) Prevención secundaria
- d) Prevención terciaria
- e) Control sanitario

70) Un paciente de 34 años, sin antecedentes, sufre caída mientras subía una escalera, resultando con golpe en su rostro, al ingreso se en buenas condiciones generales, pero con epistaxis. Se realiza especuloscopia nasal donde se aprecia engrosamiento septal bilateral y epistaxis anterior. La conducta más adecuada, en este caso es:

- a) Drenaje por punción
- b) Observar y controlar en 2 semanas
- ☒ c) Drenaje quirúrgico urgente
- d) Antibióticos endovenosos
- e) Taponamiento nasal bilateral